MÓDULO 9 · ESTRATEGIA MÉDICA Y PLAN MÉDICO

Gaps de evidencia

El Módulo 7 introdujo el concepto de gap de evidencia y el proceso para identificarlo. Esta lección aborda un ángulo distinto y complementario: cómo los gaps de evidencia se integran formalmente dentro del Plan Médico, convirtiéndose en uno de sus pilares de decisión más importantes, y no solo en una lista de observaciones sueltas del equipo de campo.

- Los gaps de evidencia se integran formalmente como pilar de decisión del Plan Médico
- El Módulo 7 introdujo el concepto; esta lección aborda su integración estratégica
- No son solo una lista de observaciones sueltas del equipo de campo

Dentro de la arquitectura de un Plan Médico, el inventario de gaps de evidencia cumple una función de diagnóstico: es la fotografía honesta de todo lo que la comunidad científica y clínica necesita saber sobre un producto o un área terapéutica y que la evidencia actual no responde satisfactoriamente. Esta fotografía se construye combinando varias fuentes, como se explicó en el Módulo 7 —revisión sistemática de literatura, análisis de guías clínicas, e insights recogidos activamente por el equipo de MSL—, y debe mantenerse viva y actualizada a lo largo de todo el ciclo del plan, no elaborarse una única vez al año y archivarse.

- El inventario de gaps es la fotografía honesta de lo que la evidencia no responde
- Se construye combinando literatura, guías clínicas e insights del equipo de MSL
- Debe mantenerse viva y actualizada todo el ciclo, no archivarse una vez al año

Una vez identificado el inventario completo de gaps, el Plan Médico exige un proceso explícito de priorización, porque casi ningún equipo tiene recursos para abordar todos los gaps identificados en el mismo ciclo. Los criterios de priorización habituales incluyen el impacto potencial en la práctica clínica (¿a cuántos pacientes afecta, y con qué consecuencia si permanece sin resolver?), la viabilidad de generar evidencia que lo resuelva en un plazo razonable, el alineamiento con los imperativos estratégicos definidos para ese ciclo, y el riesgo competitivo o reputacional de dejar ese gap sin abordar mientras otros actores del mercado sí lo hacen.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE GAPS

- Impacto potencial en la práctica clínica: a cuántos pacientes afecta
- Viabilidad de generar evidencia que lo resuelva en un plazo razonable
- Alineamiento con los imperativos estratégicos del ciclo
- Riesgo competitivo o reputacional de dejarlo sin abordar

Los gaps priorizados no permanecen como una simple lista dentro del Plan Médico: se traducen en acciones concretas dentro de las distintas palancas del plan. Un gap sobre una subpoblación no representada en los ensayos pivotales puede traducirse en una propuesta de estudio observacional o de RWE; un gap sobre comparación directa con una alternativa terapéutica puede traducirse en la priorización de un estudio pragmático; un gap sobre comprensión práctica de un mecanismo de acción puede traducirse en una prioridad del plan de educación médica en lugar de en un nuevo estudio. Esta conexión explícita entre cada gap y la acción concreta que lo aborda es lo que da coherencia interna al Plan Médico completo.

- Un gap sobre subpoblación no representada puede derivar en un estudio de RWE
- Un gap de comparación directa puede derivar en un estudio pragmático
- Un gap de comprensión del mecanismo puede derivar en educación médica
- Esta conexión explícita gap-acción da coherencia al Plan Médico

Para el MSL, participar activamente en este proceso —no solo aportando insights individuales, sino entendiendo cómo se agregan, priorizan y convierten en decisiones dentro del Plan Médico— es lo que transforma su contribución de anecdótica a estratégica, y es también lo que le permite explicar con solidez, ante un KOL que pregunta por qué determinada pregunta clínica sigue sin respuesta, en qué punto del proceso de generación de evidencia se encuentra esa cuestión concreta.

- Participar en este proceso transforma la contribución del MSL de anecdótica a estratégica
- Permite explicar a un KOL en qué punto del proceso está una pregunta clínica sin respuesta